

ホルモン療法(内分泌療法):薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 年単位の服薬継続の支援(残薬・自己中断の確認)
- ☐ ほてり・関節痛など継続の妨げになる症状の聴取と対処
- ☐ アビラテロンの空腹時服用・プレドニゾン併用の確認
- ☐ 他院の抗うつ薬・抗凝固薬・スタチン等の相互作用確認
- ☐ 骨の健康(カルシウム・歯科受診)の指導と情報提供

病院薬剤師

- ☐ 閉経状況・受容体・治療期間とレジメンの整合性の確認
- ☐ LH-RH製剤など注射の投与スケジュール管理
- ☐ 骨密度検査・骨を守る薬の導入の提案
- ☐ アビラテロン開始時の肝機能・カリウムの確認
- ☐ お薬手帳への治療目的・予定期間の記載

病院と共有する情報

治療目的・予定期間

骨密度・検査値

副作用と服薬状況

自己中断の有無と理由

2 主な薬剤の服用方法と薬局での確認ポイント

薬剤	用法	特徴的な副作用	薬局での確認ポイント
タモキシフェン	1日1回、5～10年	ほてり、静脈血栓塞栓症、子宮内膜の変化	不正性器出血・片足の腫れ、CYP2D6阻害薬の併用
アロマターゼ阻害薬	1日1回、5年～	関節痛・こわばり、骨密度低下	骨密度検査・骨粗鬆症治療薬、関節痛での自己中断
LH-RHアゴニスト	皮下注射(1・3・6か月ごとの製剤)	ほてり、骨密度低下、開始初期のフラア	次の注射日、骨の健康
アビラテロン	1日1回 空腹時、プレドニゾンと併用	低カリウム血症、高血圧、浮腫、肝機能障害	食事の1時間前～食後2時間を避ける、プレドニゾンの継続
エンザルタミド アパルタミド	1日1回	疲労、転倒・骨折、皮疹(アパルタミド)	他院処方への影響(酵素誘導)、転倒、皮疹
ダロルタミド	1日2回 食後	疲労(比較的少ない)	食後服用、ロスバスタチンとの併用

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン CYP2D6阻害(活性化↓)	処方薬 パロキセチン等の強いCYP2D6阻害薬	活性代謝物↓→効果減弱のおそれ	他院の抗うつ薬を確認し、代替を処方医と相談
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン 抗凝血作用の増強	処方薬 ワルファリン	INR↑→出血	INR測定の前を確認
注意 添付文書 併用注意	エンザルタミド・アパルタミド 代謝酵素の誘導	処方薬 ワルファリン・一部のDOAC・睡眠薬等	併用薬の濃度↓→効果減弱	他院処方を確認し、効果の低下を処方医と共有
注意 添付文書 併用注意	ダロルタミド BCRP等の阻害	処方薬 ロスバスタチン	ロスバスタチン濃度↑	スタチンの用量と筋肉痛を確認
注意 添付文書 用法・用量	アビラテロン 食事で吸収が増加	生活習慣 食事と一緒に服用	血中濃度が大きく上昇→副作用↑	食事の1時間前～食後2時間を避けて服用
注意 添付文書 併用注意	内分泌療法全般 作用の拮抗	処方薬 エストロゲン製剤(ホルモン補充療法等)	治療効果の減弱	婦人科など他院の処方を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始時

「この治療は年単位で続けることで再発を防ぎます。飲み忘れを防ぐ工夫と一緒に考えましょう」

確認:治療目的・予定期間、閉経状況、他院の抗うつ薬・抗凝固薬

△ アビラテロンは空腹時の服用を具体的に説明

1～3か月

「ほてりや関節の痛みはありませんか。続けにくいと感じたら教えてください」

確認:副作用と対処法、注射の予定、血圧・カリウム(アビラテロン)

△ 片足の腫れ・急な息切れは血栓症を疑い至急受診

半年～1年

「骨密度の検査は受けましたか。カルシウムやビタミンDをとり、体を動かしましょう」

確認:骨密度検査・骨粗鬆症治療薬、歯科受診(骨の薬を使う場合)

△ 転倒・骨折のリスクを評価

年単位

「ここまで続けられていますね。気になる症状は変わりありませんか」

確認:残薬と服薬継続、不正性器出血(タモキシフェン)

△ 自己中断があれば理由を聞き処方医と共有